

30 - 01- Le Cancer de l'Estomac - Pr. Rabbani

Bonjour, notre cours d'aujourd'hui s'intitule le cancer de l'estomac. Comme objectif, vous devez connaître les différents facteurs favorisant de ce cancer, ainsi que les lésions pré-cancéreuses qui vont se transformer en cancer de l'estomac. Il faut aussi connaître le tableau clinique et les signes cliniques évocateurs.

Il faut savoir poser le diagnostic du cancer gastrique, faire le bilan d'extension et connaître la prise en charge de ce cancer. Le plan va être comme suit. Comme prérequis, vous devez connaître l'anatomie de l'estomac, les rapports de l'estomac et les moyens de fixité, la vascularisation artérielle et surtout la vascularisation lymphatique de l'estomac.

Alors, en guise d'introduction, le cancer de l'estomac, c'est une prolifération tumorale maligne au niveau de la paroi gastrique qui est dominée par l'adénocarcinome. Il a une symptomatologie qui est variable et l'endoscopie reste l'examen paraclinique qui permet la confirmation avec biopsie de ce cancer. Le traitement repose essentiellement sur la chirurgie.

Malheureusement, le pronostic reste mauvais vu que la survie à 5 ans ne dépasse pas les 15%. D'où l'intérêt de dépister ce cancer à un stade précoce et aussi le rôle de la prévention de ce cancer. Alors, comme rappel anatomique, comme vous le connaissez, l'estomac, c'est la partie du tube digestive qui fait suite à l'osophage, sa partie sous-diaphragmatique.

Il est composé par une grosse tubérosité, par ou bien un fendus, par un corps gastrique et par une région antrypylorique. Il est constitué par deux courbures, la petite courbure et la grande courbure. Au niveau de sa partie droite, il est fixé au foie par le ligament oeso-gastro-diodeo-hépatique, ou bien le petit épiplan, et à sa gauche, il donne insertion au grand menton ou au grand épiplan, et à sa partie totalement à gauche, il est fixé à la rate par l'épiplan gastro-spilénique, et sa partie supérieure est fixée au diaphragme par l'épiplan gastro-phrynique.

Il entre en rapport avec plusieurs organes. Au niveau de sa partie postérieure, on voit ici une coupe de l'estomac. Sa partie postérieure, c'est ce qu'on appelle l'arrière-cavité des épiplans, la bourse en mental, qui entre en rapport avec le corps du pancréas, qui entre en rapport aussi avec la rate, plus en dehors.

Il entre en rapport à distance par les gros vaisseaux. A droite, il répond au pédicule hépatique et au petit épiplan, et au foie. A gauche, il répond à sa partie plus à gauche, donc il répond au diaphragme, à la rate, et à l'angle colique gauche.

Ce cancer représente la deuxième cause de mortalité dans le monde. Il est classé en troisième dans les cancers digestifs précédés par le cancer du collant et le cancer du rectum. Dans la région de Marrakech, les statistiques ou le registre de cancers de la région de Marrakech le classent parmi les premiers cancers digestifs.

Son incidence est élevée dans le Japon, il est faible en Europe, et il atteint beaucoup plus la population, qui est supérieure à 50-55 ans. Il touche les hommes plus que les femmes, avec un sexe ratio de 2 à 3 ans, pas pour une femme. Il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent intervenir dans l'installation ou la survenue de ce cancer, notamment des facteurs de risque exogènes, et il y a des facteurs de risque qui sont endogènes.

Concernant les facteurs de risque exogènes, surtout en rapport avec l'alimentation, l'alimentation salée favorise le cancer de l'estomac. Il y a des facteurs génétiques, il y a des familles de cancers de l'estomac. Il y a aussi la bactérie, ce qu'on appelle l'hélicobactère pylorique, qui est responsable de l'ulcère ou de la gastrite, et incriminée dans la survenue de cancers gastriques.

L'intoxication alcool-tabagique, le niveau socio-économique bas, et bien sûr le régime alimentaire, qui est pauvre en fruits et en légumes. On a aussi des lésions qui sont précancéreuses, notamment la maladie de Ménétrier, qui se définit par une gastropathie hypertrophique géante, qui se manifeste cliniquement par un manque d'appétit, par des brûlures et par des épigastalgies. Il y a aussi la maladie de Biermer, qui se définit par une carence en acide folique ou vitamine B12.

C'est une anémie qui est mégaloblastique et se définit par la présence dans la moelle d'erythroblast. Le risque de survenue de cancers après ces lésions prédisposantes est multiplié par 3. Il y a aussi la gastrite chronique atrophique, c'est une lésion précancéreuse. C'est un processus chronique qui commence par une inflammation de la muqueuse qui va se répéter et par la suite va devenir une lésion chronique.

Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une perte de cellules glandulaires gastriques qui vont être remplacées par des cellules intestinales et fibreuses. Alors, ça va bien sûr retentir sur les sécrétions, donc la sécrétion de l'estomac et des substances essentielles telles l'acide chlorhydrique et la pepsine et les facteurs intrinsèques qui vont être altérés par cette inflammation chronique. Il y a d'autres lésions précancéreuses, notamment les polypes adénomateux.

Alors, les polypes adénomateux, c'est toute lésion qui est sessile ou pédiculée qui déborde sur la muqueuse, ça s'appelle un polype. Donc, il y a des polypes qui sont précancéreux, il y a des polypes qui ne le sont pas. Les polypes adénomateux, ce sont des polypes qui sont néoplasiques.

Ils représentent 10% de l'ensemble de tous les polypes gastriques. Généralement, ils mesurent moins de 2 cm. Quand le volume ou bien quand le diamètre est augmenté, le risque de dégénérescence est élevé.

Ils siègent volontiers au niveau de l'entre-gastrique et ils sont souvent polypoides ou bien sessiles ou pédiculés. Il y a aussi, parmi les facteurs de risque, les patients qui ont déjà eu une

gastrectomie, soit pour ulcère, soit pour cancer. Alors, vous voyez ici, on voit ici de multiples nodules gastriques au niveau de la paroi gastrique, au niveau de la muqueuse.

Là, on voit un pseudopolype inflammatoire. Là, on voit une ulcération de la région entrale. Ici, donc, c'est des polypes ombiliqués.

Donc, c'est ce qu'on appelle les tumeurs stromales, les gistes. Là, c'est un nodule bulbaire. Et là, c'est des pseudopolypes, plusieurs polypes, donc au niveau de la muqueuse gastrique.

Alors, concernant l'histologie, le siège de ce cancer, l'adénocarcinome, donc, il siège le plus souvent, ou bien le cancer de l'estomac, il siège le plus souvent au niveau de la région entrale, dans la moitié des cas, suivi par le corps, dans 20% des cas, et le fundus, dans 20% des cas. Parfois, on peut avoir un cancer qui siège sur toute la paroi gastrique, c'est ce qu'on appelle les lignites gastriques. Alors, macroscopiquement, les lésions, elles sont végétantes, c'est des masses qui sont ulcérées généralement, ou bien ulcéro-végétantes et infiltrantes, ou bien une lignite, c'est une infiltration qui est massive et circonscrite de toute la paroi, on parle ici de type histologique, ce qu'on appelle les cellules en bagues à chatons.

Donc l'adénocarcinome, c'est le type histologique le plus fréquent, il représente presque 90% des cas des cancers de l'estomac, suivi par d'autres types, comme la lignite gastrique, qui est aussi un adénocarcinome, mais c'est un adénocarcinome qui est diffus et infiltrant, se manifeste par un épaississement de la paroi gastrique par un processus néoplasique, son diagnostic, il repose sur des arguments histologiques, anatomopathologiques, mais aussi sur des arguments endoscopiques où on va trouver un estomac qui est tubulé, comme un tube rigide, avec des gros plis, et même à la radiologie, à l'écho-endoscopie, on peut trouver un aspect de lignite gastrique avec un estomac en tube. Le troisième type, donc, c'est les lymphomes nonhodgkiniens, qui représentent 3% de tous les cancers gastriques, généralement ce sont des tumeurs qui se développent dans les tubes, ce ne sont pas des lymphomes de Hodgkin, mais ce sont des lymphomes qui sont nonhodgkiniens. Le lymphome, comme vous le savez, c'est un cancer du système lymphatique, et qui va dépendre des lymphocytes, au niveau de la moelle osseuse, au niveau des ganglions lymphatiques, et au niveau des vaisseaux lymphatiques.

Donc, il y a d'autres tumeurs, comme les GIST, les gastrointestinal stromal tumors, donc ce sont les tumeurs qui sont, ce sont les tumeurs mesenchymateuses qui sont des cellules des caecales au niveau des tissus conjonctives, il y a les carcinomes épidermoïdes, et il y a les tumeurs neuroendocrines, et aussi les sarcomes. Il y a une classification, c'est ce qu'on appelle la classification TNM, T ça veut dire la localisation de la tumeur au niveau des couches, N c'est l'adénopathie, et M c'est les métastases. Alors concernant le diagnostic positif du cancer de l'estomac, on va prendre comme type de description un adénocarcinome gastrique, surtout chez un jeune de 65 ans.

Alors les signes d'appel, ou bien les signes fonctionnels, le patient vient consulter pour des

épigastralgies. Généralement ce sont des épigastralgies qui sont un petit peu caractéristiques, donc c'est des douleurs dont il survient à jeun, et ce sont des douleurs qui ne sont pas calmées par une position, mais qui sont généralement calmées par les repas. Le motif le plus fréquent, on a dit que ce sont des douleurs, ils sont donc à type de douleurs ulcéreuses, ce sont des douleurs parfois qui ne sont pas spécifiques, parfois on peut trouver même un tableau de dyspepsie, et il y a d'autres signes accompagnateurs, notamment des signes qui sont en rapport avec l'évomisement, l'anorexie, l'altération de l'état général, une fatigue qui est due à l'anémie, parfois une dysphagie lorsque la tumeur est sténosante, on parle bien de la tumeur au niveau du cardia, et les vomissements qui peuvent évoquer un cancer du pylore en provoquant une sténose pylorique.

Toujours dans les signes fonctionnels, on peut diagnostiquer le cancer aussi par une complication, soit une sténose, soit les hémorragies, ou bien la péritonite, une perforation gastrique, donc la sténose antropylorique se manifeste par des vomissements postprandiaux tardifs, et parfois par un état de déshydratation avec une pâleur, parfois une asthénie, ou bien par une hémorragie digestive qui se manifeste aussi par un saignement soit haut, soit bas, c'est-à-dire soit par une amathémèse ou bien une méléna, et se manifeste par une anémie, et cliniquement par une asthénie. Donc le tableau de péritonite, c'est la perforation gastrique tumorale. A l'examen clinique du patient, le plus souvent il est normal.

Parfois on peut trouver une masse épigastrique qui témoigne d'un signe métastatique, notamment une hépatomégalie qui témoigne d'un foie métastatique, une matité abdominale avec une distension abdominale qui témoigne d'une ascite carcinomateuse, la palpation des aires ganglionnaires peut trouver un ganglion de troisième au niveau de l'aire susclaviculaire gauche, et aussi il faut apprécier l'état nutritionnel en recherchant les signes de la déshydratation. A la palpation, il faut chercher les plis de déshydratation, une sensibilité, une défense. A la percussion, il faut chercher une matité, notamment une ascite.

Et au toucher rectal, il ne faut pas oublier de chercher les nodules du cul de sac. Alors au total, le diagnostic de cancer gastrique, clinique, il se fait par épigastralgie plus une anémie. Donc il faut toujours penser à un cancer de l'estomac et de ses deux signes.

Alors là, c'est un tableau qui montre des signes d'alarme et bien sûr la conduite à tenir. Lorsqu'on a un patient supérieur à 50 ans, tabagique, il y a tous les facteurs de risque avec une masse abdominale, dysphagie, hémorragie digestive qui vient d'une région ethnique, notamment le Japon où il y a beaucoup de cancers de l'estomac. Donc là, il faut, s'il y a de la présence de signes d'alarme, c'est l'indication formelle à faire une fibroscopie œsogastro-dodénale qui va permettre de faire le diagnostic de ce cancer à travers une biopsie.

Alors c'est quoi la fibroscopie œsogastro-dodénale? C'est un tube qu'on introduit au niveau de la bouche du patient et donc on va explorer la muqueuse œsophagienne, la muqueuse gastrique et la muqueuse dodénale. Il permet aussi d'évaluer l'état de la tumeur. Il permet de faire des

biopsies.

Généralement, il faut faire plusieurs biopsies, une dizaine de biopsies. Alors la fibroscopie doit être faite devant tout signe qui fait suspecter le cancer gastrique, notamment une hémorragie ou bien une anémie. Il y a d'autres moyens diagnostiques, notamment radiologiques.

C'est ce qu'on appelle le TOGD ou bien le transit oesogastro-diodénale. C'est un tube à ingérer de la barite. C'est un produit qui est radio-opaque et on fait une radio, donc ça va se colorer en blanc.

C'est une opacité, donc on va voir l'oesophage, l'estomac, le pylore et le diodénome. Ce n'est pas un examen de première intention, mais on peut le demander, surtout lorsque la tumeur est complètement sténosante au niveau du cardiaque et on n'arrive pas à voir l'état de l'estomac. Il y a aussi des images d'addition lorsqu'il y a des ulcères ou bien des images de soustraction lorsqu'il y a des tumeurs qui sont bourgeonnantes.

Concernant les diagnostics différentiels des cancers gastriques, c'est l'ulcère gastrique, c'est le même tableau, c'est des épigastalgies, sauf que la différence entre ulcère gastrique et cancer gastrique, c'est l'état général qui est conservé dans l'ulcère gastrique. Les tumeurs non adélocarcinomateuses, notamment les lymphomes, les tumeurs stromales, les tumeurs endocrines ou bien les lymphomes qui sont variables selon la localisation ou selon la complication ou bien même selon l'âge. Selon la localisation, il y a les cancers du cardiaque ou bien le cancer de la jonction oeso-gastrique.

Selon les types histologiques, c'est les différents types histologiques qu'on a cités tout à l'heure. Selon la complication, ça dépend de la complication. Est-ce que c'est une complication hémorragique, est-ce que c'est une complication mécanique sténosante ou bien est-ce que c'est une complication de perforation péritonite.

Alors, une fois le diagnostic suspecté et posé par une fibroscopie avec des biopsies, il faut poser la question. Est-ce que ce patient ou bien cette tumeur, elle est résécable par la chirurgie ou pas? Alors, pour voir est-ce qu'il est résécable ou pas, il faut faire le bilan d'extension. Alors, le bilan d'extension, c'est quoi? Est-ce que la tumeur est toujours localisée au niveau de l'organe, c'est-à-dire au niveau de l'estomac ou bien est-ce qu'elle est étendue à d'autres organes? C'est ce qu'on appelle une situation métastatique.

Alors, il y a le bilan d'extension. Ça commence toujours par la clinique. Donc, cliniquement, on va examiner le patient.

On va chercher s'il n'y a pas d'adénopathie susclaviculaire de Troisier qui témoigne d'une métastase ganglionnaire à distance. On va chercher l'hépatomégalie qui témoigne d'une métastase hépatique. Et on va chercher aussi, est-ce qu'il n'y a pas une distension abdominale, notamment une à site ou bien au toucher rectal, est-ce qu'il n'y a pas des nodules de carcinose

péritoniale? Alors, après l'étape clinique, on passe à l'étape paraclinique.

C'est l'échographie abdominopelvienne et aussi le scanner abdominopelvien. Donc, l'échographie, ça montre des métastases, ça montre de la site aussi. Alors, le scanner, il est plus performant.

Il faut faire un scanner thoraco-abdominopelvien. Donc, il faut balayer tout le trans et chercher est-ce qu'il n'y a pas des métastases pulmonaires, est-ce qu'il n'y a pas des métastases hépatiques et est-ce qu'il n'y a pas des métastases qui sont péritoniaux et chercher aussi est-ce qu'il n'y a pas une métastase ovarienne des tumeurs du tube digestif. C'est ce qu'on appelle les tumeurs de Krukenberg.

Alors, il y a aussi un autre moyen de bilan d'extension radiologique et endoscopique en même temps. C'est ce qu'on appelle l'écho-endoscopie. Il est supérieur au scanner et à l'échographie.

Il apprécie la filtration en profondeur au niveau de toutes les couches de l'estomac. Il permet aussi d'étudier l'envahissement ganglionnaire et il a un intérêt important dans les tumeurs qui sont superficielles et quand on suspecte aussi des tumeurs électriques. Alors, la radio du poumon, c'est un examen qu'on peut aussi demander, mais si on demande un TAP ou bien un scanner thoraco-abdominopel, il n'y a pas la peine de demander la radiographie.

Donc là, vous voyez la radiographie. Il y a des images qu'on appelle des métastases pulmonaires en lâchés de ballon. Il y a aussi un autre moyen de bilan d'extension.

C'est ce qu'on appelle la laparoscopie exploratrice. On introduit un optique à l'intérieur de l'abdomen pour voir en clair ce qui se passe à l'intérieur de la cavité abdominale. Est-ce qu'il y a une ascite et est-ce qu'il y a une carcinose péritoniale ? Et de là, on va dire, est-ce que la résectabilité est faisable ou douteuse ? Il y a aussi les marqueurs tumoraux.

C'est ce qu'on appelle l'antigène carcinome embryonnaire, le F9. Leur intérêt dans le bilan d'extension n'est pas démontré, mais ils ont intérêt beaucoup plus lors de la surveillance d'un malade qui a un cancer et qui a été opéré. Alors, une fois posée la question sur la résectabilité de la tumeur et en fait le bilan d'extension, il faut se poser la question aussi, est-ce que ce patient est opérable ? On parle de son état général.

Si le patient n'est pas opérable, ça veut dire que le patient a une tare, il a une contre-indication, il ne peut pas supporter l'anesthésie. C'est pour ça qu'il faut demander un bilan complet, notamment une NFS, un bilan hydroélectrolytique, un ECG, une fonction rénale, une radio-thorax, l'état nutritionnel aussi pour voir le taux de l'albuminémie et de protidémie. Alors, une fois le diagnostic fait, le bilan d'extension fait, on doit passer au traitement.

On sait que la chirurgie, c'est le seul moyen thérapeutique curatif du cancer de l'estomac. Ce traitement doit être envisagé dans une réunion de concertation pluridisciplinaire qui rassemble un

gastro-entérologue, un oncologue, un radiologue, un anatomopathologiste et un chirurgien. Le but de ce traitement, c'est de réséquer la tumeur, de nourrir le patient, de faire un curage ganglionnaire, parce que le cancer de l'estomac, c'est un cancer qui est lymphophile, c'est-à-dire qu'il aime beaucoup les adénopathies, donc il faut enlever l'estomac et l'atmosphère ganglionnaire qui est autour.

Rétablir la continuité digestive, parce qu'on va couper, enlever l'estomac, donc on doit rétablir la continuité entre le zoophage et le tube digestif. Pour être le moins nocif pour le patient. Parmi les méthodes, on va commencer par la chirurgie.

Il y a plusieurs voies d'abord de la chirurgie. Il y a ce qu'on appelle la laparotomie ou la laparoscopie. La laparotomie, c'est la chirurgie à ciel ouvert, c'est la chirurgie classique.

On aborde le patient par une cicatrice médiane susombilicale, c'est-à-dire au-dessus de l'ombilique qui passe par la ligne blanche qui commence par l'appendice xiphoïde jusqu'à l'ombilique. La laparoscopie, c'est l'introduction des trocars à l'intérieur de l'abdomen, insufflation d'un gaz qui est le CO₂ et on travaille à travers une vue vidéoscopique. Il y a deux types de chirurgie.

Il y a la chirurgie curative et la chirurgie palliative. La chirurgie curative, c'est dans un but curatif, c'est-à-dire s'il n'y a pas de métastase, s'il n'y a pas d'autres localisations, donc on est dans un but curatif, c'est-à-dire enlever la tumeur et donc enlever toute la tumeur. Il y a les gastrectomies totales, c'est-à-dire on enlève tout l'estomac et on le remplace par un segment d'étude digestive.

Il y a les gastrectomies subtotaux, on enlève juste les 4-5ème de l'estomac. On peut faire aussi, on doit faire aussi des curages ganglionnaires, il y a plusieurs types de curages, il y a le curage D1, D2, D3, donc on ne va pas les détailler ici, mais c'est des curages qui doivent être faits, qui dépendent de la localisation, qui dépendent du type histologique de la tumeur. Donc le rétablissement de continuité, ça peut être soit un rétablissement oeso-géjunal lorsqu'on fait une gastrectomie subtotale. Alors là ici, on voit quelques pièces de tumeurs gastriques, donc là on voit, c'est un giste, une tumeur stromale qui se développe au niveau du tissu conjonctif, là on voit l'estomac, là on voit le grand timentin, donc c'est une gastrectomie en portant le giste parce que c'est un giste qui était volumineux.

Ici on voit, c'est une gastrectomie oitotale donc c'est une gastrectomie en portant le grand timentin. Alors il y a aussi la chirurgie palliative. La chirurgie palliative, c'est dans les cas où la tumeur est étendue vers d'autres organes ou bien elle n'est pas résécable, c'est-à-dire soit métastatique, soit non résécable, donc là la chirurgie a un rôle juste pour améliorer la qualité de vie et pour enlever l'obstacle parfois.

Alors il y a des dérivations, ce qu'on appelle l'anastomose, c'est-à-dire anastomose entre l'estomac et le grêle, c'est ce qu'on appelle gastroentéro-anastomose. Il y a aussi l'estomie, on peut faire des gestionostomies, on peut faire des gastrostomies d'alimentation lorsqu'il s'agit de

tumeurs par exemple qui sont osituées au niveau du cardia, et on peut même faire des gastrectomies palliatives de propreté ou bien hémostatiques, parfois des patients qui ont des hémorragies digestives foudroyantes de secondaire, un cancer de l'estomac qui n'est pas capable, donc là il faut essayer de faire la résection juste pour arrêter le saignement. Alors le deuxième volet thérapeutique ou deuxième moyen thérapeutique, c'est le moyen endoscopique.

Alors pour les moyens endoscopiques, là aussi deux objectifs, soit curatif, soit palliatif. Alors le curatif, ce n'est possible que dans les cas des cancers superficiels, c'est-à-dire des cancers qui sont situés au niveau de la muqueuse, qui ne dépassent pas la muqueuse, donc là on peut faire des résections muqueuses, c'est ce qu'on appelle les mycosectomies, ou bien les DSM, les dissections sous-muqueuses. Dans un but palliatif, c'est pour mettre des endoprothèses lorsqu'il y a des sténoses, c'est pour scléroser ou bien traiter l'hémorragie par du plasma argant, ou bien l'application de poudre hémostatique, ou bien une photothérapie.

Il y a d'autres moyens aussi thérapeutiques, notamment la chimiothérapie, qui peut être utile soit dans un but curatif ou dans un but palliatif. Dans un but curatif, on peut la mettre en concomitance avec le traitement chirurgical, on peut la mettre dans un protocole, ce qu'on appelle le protocole magique, on peut faire une chimiothérapie pré et post-opératoire. On fait une chimiothérapie première, on opère le patient et on fait une chimiothérapie post-opératoire.

Cette technique ou ce protocole magique, c'est améliorer la qualité de vie et augmenter la survie à cinq ans. Alors, il y a des traitements aussi qui sont adjuvants, la radiochimiothérapie, on peut même faire une radiochimiothérapie lorsqu'on n'a pas fait de chimiothérapie première, c'est ce qu'on appelle le protocole de MacDonald. La radiothérapie, c'est une irradiation de la tumeur par des rayons, ça peut être en pré et en post-opératoire, et parfois il est indiqué dans les tumeurs qui saignent, c'est-à-dire une hémorragie digestif, un cancer gastrique qui saigne et qui n'est pas opérable.

Donc là, on peut faire une radiothérapie hémostatique. La chimiothérapie aussi, ça peut être indiqué dans les stades avancés ou dans les métastases, c'est dans un but palliatif, comme ça peut être dans un but curatif, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est le protocole de MAGIC. Alors concernant les indications, pour les cancers qui sont réséquables, lorsqu'il s'agit d'un cancer de l'entre-gastrique, on va faire une gastrectomie totale, pardon, subtotale, avec une anastomose gastrogéginale et curage gonglionaire.

Lorsque la tumeur est située au niveau de la grosse tubérosité, là, il faut faire une gastrectomie totale avec une anastomose enzo-géginale, entre l'enzophase et l'enzo-géginale, avec un curage gonglionaire. Lorsque la tumeur est située au niveau de la grosse tubérosité, c'est l'enzo-gastrectomie polaire supérieure, c'est-à-dire on enlève une partie de l'enzo-phase et la partie supérieure de l'estomac, et faire une anastomose enzo-géginale ou bien enzo-colique. Alors la radiothérapie ou la radiochimiothérapie peut être proposée aussi en fonction des stades de TNF.

Alors lorsque les tumeurs, ou bien le cancer, il n'est pas résectuable, mais non métastatique chez un malade qui est opérable, il faut faire une chimiothérapie et réintervenir par la suite pour voir est-ce que c'est faisable ou pas. Pour les cancers qui sont résectables, mais le malade non opérable, donc là c'est l'option des autres traitements, surtout la chimiothérapie, pose de prothèse lorsqu'il est sténosant, et notamment aussi le traitement endoscopique, les mycoscopes. Alors pour les cancers avec une résection qui est incomplète, c'est-à-dire on résecte la tumeur, mais on a laissé aussi de la tumeur à l'intérieur, il faut compléter par une radiochimiothérapie.

Et pour les cancers bien sûr métastatiques, il faut faire une chimiothérapie. Concernant les résultats de ce cancer de l'estomac, la mortalité malheureusement est de 5%, la morbidité, c'est-à-dire les complications de cette chirurgie, c'est surtout les fistules anastomotiques, un choc hémorragique, un choc hémorragique secondaire à une hémorragie d'un vaisseau gastrique, des complications de décubitus, notamment les infections respiratoires, un sepsis intra-abdominal et pariétal, qui peut être dû à une fistule anastomotique. La survie à 5 ans, globalement elle est de 15%, tous les stades confondus.

Il y a aussi des complications qui sont à distance, notamment des diarrhées, le dumping syndrome et les amaigrissements. Alors c'est quoi le dumping syndrome ? C'est un syndrome qui se manifeste chez les patients qui ont des gastrectomies et qui ont des vivagotomies. Lorsque le patient mange, il sent un malaise juste en postprandiale et donc qui est dû à une mauvaise vidange gastrique, donc c'est une vidange gastrique qui est rapide et le patient va exprimer les signes de lipoglycémie avec une diarrhée.

Quand on a eu le traitement, il faut bien sûr les surveiller, il y a un rythme de surveillance, tous les trimestres pendant la première année et après, tous les 6 mois pendant les autres années et puis au-delà de 2 ans, un contrôle tous les ans. Cette surveillance peut être clinique et doit être clinique, radiologique et endoscopique. Les éléments de pronostic, c'est surtout l'extension en profondeur, c'est le T, c'est l'atteinte ganglionnaire, c'est le N et bien sûr, c'est l'extension métastatique, c'est le M et aussi la différenciation cellulaire.

Par exemple, plus la différenciation cellulaire va vers l'indifférent ou le peu différencié, plus le pronostic est mauvais. Alors en conclusion, le cancer de l'estomac est un cancer qui est de très mauvais pronostics, d'où l'intérêt de l'endoscopie précoce, qui reste le seul traitement curatif. L'intérêt du dépistage des cancers du côlon dans les familles des cancéreux ou bien dans les régions où il y a une forte prévalence et incidence.

Il faut donc jouer sur le rôle de la prévention pour éradiquer le *mycobacter pylori* qui est incriminé dans la cancérogénèse. Éviter le tabac aussi. Une bonne hygiène de vie en évitant l'alimentation salée et en surveillant les lésions précancéreuses qui peuvent évoluer vers le cancer gastrique.